

산디문 복용 중, 고지혈증약이 바뀐 이유

산디문(사이클로스포르린)은 꼭 필요한 약이지만, 일부 고지혈증약의 혈중농도를 크게 올릴 수 있습니다. 그래서 **남은 약을 임의로 다시 먹지 말고**, 처방된 약과 검사 일정대로 안전하게 조절하는 것이 중요합니다.

핵심만 먼저

로수바스타틴 노출

약 7배 ↑

산디문 병용 시 보고

에제티미브 노출

약 3.4배 ↑

신장기능 저하 시 더 클 수 있음

현재 방향

낮은 상호작용

스타틴 선택 + 병용약 모니터링

바로 연락

근육통·갈색뇨

횡문근융해 의심 신호

왜 조심해야 하나요?

STEP 1

산디문이 통로를 막음

간으로 약이 들어가는 수송체와 일부 대사 경로가 억제됩니다.

STEP 2

스타틴 농도 상승

일부 스타틴은 혈중농도가 크게 올라 근육 부작용 위험이 커집니다.

STEP 3

약을 골라서 사용

프라바스타틴·플루바스타틴 등 상대적으로 안전한 선택지를 우선 검토합니다.

오늘부터 지킬 것

🔊 남은 고지혈증약을 임의로 재복용하지 마세요

특히 **로수바스타틴·심바스타틴·로바스타틴·피타바스타틴** 계열은 산디문과 병용 제한이 있을 수 있습니다. 처방전 그대로만 복용하세요.

📞 새 약·항생제·건강기능식품은 먼저 알려주세요

산디문은 상호작용이 많은 약입니다. 다른 병원 처방, 약국 일반약, 보충제를 시작하기 전 **산디문 복용 중**이라고 말해 주세요.

🔊 에제티미브는 사용 가능하지만 검사와 함께 갑니다

에제티미브는 금기약은 아니지만 산디문 농도와 에제티미브 노출이 함께 오를 수 있어, 필요 시 **산디문 혈중농도·신장기능**을 확인합니다.

📋 검사 일정은 약효 확인과 안전 확인을 같이 봅니다

LDL 콜레스테롤 반응, 간수치, 신장기능, 근육 증상 여부를 함께 봅니다. 증상이 있으면 CK 검사를 추가할 수 있습니다.

이런 증상은 바로 병원에 연락하세요

MUSCLE

새로운 근육통

허벅지·어깨가 이유 없이 아프거나 놀러도 아픔

WEAKNESS

힘 빠짐

계단 오르기·의자에서 일어서기가 갑자기 힘들

URINE

진한 갈색 소변

콜라색 소변, 소변량 감소, 붓기 동반

SYSTEMIC

열·심한 몸살감

근육 증상과 함께 열, 극심한 피로가 있으면 즉시 상담

다음 진료 전 체크리스트

1 **복용 중인 약 사진**을 모두 찍어 오세요. 타 병원 처방과 보충제도 포함합니다.

2 **근육통·소변색·붓기**가 있었는지 날짜와 함께 적어 오세요.

3 검사 전에는 산디문 복용 시간과 채혈 시간을 **의료진 안내대로** 맞춥니다.

4 목표 LDL에 못 미치면 증량보다 **PCSK9 억제제** 등 **상호작용 적은 옵션**을 검토할 수 있습니다.

핵심은 산디문을 안전하게 유지하면서 LDL을 낮추는 것입니다. 약을 스스로 끊거나 예전 약으로 되돌리면 산디문 농도·근육 부작용·신장 기능에 문제가 생길 수 있습니다.

